



Crise

A palavra “crise” anda por todo canto – virou sinônimo de problema, confusão e prejuízo. Crise política, crise climática; em casa, outro suspira: “Meu filho, adolescente em crise”. De tanto repetirmos, parece parte natural da vida (e, em parte, é).

Hoje é comum pensar essa palavra com o tom de catástrofe, rompimento e, geralmente, com grande necessidade de controle e segurança. Controle este que trará, de alguma forma, certa violência também. Mas não é só isso. Se escutarmos com mais atenção, veremos que crise não é apenas pane: pode ser um trecho do caminho em que o terreno bifurca, o passo desacelera – ou acelera – e a gente precisa escolher um rumo, uma velocidade. Uma imagem que Guimarães Rosa tão bem colocou: “O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta” (Rosa, 2019). As questões aparecem: Para onde vou? Com quem? Há lugares do percurso em que, mesmo rodeados de seca, ainda se encontra frescor: um banco embaixo da árvore; uma senhora que oferece um copo d’água gelado; gente que oferece companhia, ou uma carona; uma pausa que devolve o fôlego. É aí que a ruptura pode virar passagem.

A palavra “crise” vem do grego *krísis*, que significa decisão, juízo, separação, momento decisivo de escolha. Na medicina antiga, designava o instante em que o corpo definia o rumo da doença: se o paciente iria à cura ou à morte. No campo político, expressa o ponto em que uma sociedade precisa decidir seu futuro. Em todos os casos, trata-se de um tempo-limite, uma fronteira na qual algo pode mudar.

A psiquiatria, durante muito tempo, ficou “refém da teoria da crise”, mesmo que a medicina no geral a tenha abandonado. Era o único modo de fazer o diagnóstico absoluto. Isso acontece porque com a crise é como se tivéssemos um carimbo final: É louco ou não? Oferece risco ou não? Esse caminho é quase independente de um diagnóstico, o que possibilita estratégias padronizadas e supostamente mais eficazes. O paciente é visto a partir de seu corpo biológico, e pensando como um exemplar isolado da espécie. O que é importante é restaurar o equilíbrio anterior, mesmo que aparente, reduzindo o sintoma.

Em saúde mental, no contexto das reformas da psiquiatria, a crise é um conceito importante para ser repensado. No dia a dia do cotidiano dos serviços, muitas vezes é o momento em que um sofrimento se torna insuportável – para quem o vive e para quem está ao redor. Pode ser percebido primeiro por seus efeitos diversos: uma tentativa de suicídio, uma explosão de raiva, uma saída não negociada, um silêncio que dura dias. O rompimento de um vínculo importante, a perda de



um trabalho, o uso intensivo de drogas ou a simples exaustão de um corpo e mente que já não conseguem sustentar o peso de existir. Os sintomas aqui deixam de ser um sinal a ser cortado, mas contam algo, uma ou várias histórias. É preciso saber ouvir e ver para se dar conta de quais histórias são essas e poder contá-las. Antigas ou atuais, essas histórias é que fomentam o trabalho em saúde.